

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS (CAE)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación Multidimensional de Estrategias y Estilos de Coping

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE).
Nombre Original (Español)	Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE; 42 reactivos).
Autores Originales	Drs. Bonifacio Sandín y Paloma Chorot (2003), UNED, Madrid, España.
Publicación de Referencia	<i>Revista de Psicopatología y Psicología Clínica</i> (RPPC), 8(1), 39-54.
Eje Clínico y Constructo	Eje II: Procesos Psicológicos. Estrategias de Afrontamiento, Resiliencia y Regulación TCC.
Tipo de Instrumento	Autoinforme psicométrico multidimensional de 42 reactivos con escala Likert de 5 puntos (0 a 4).
Población y Rango	Adultos y adolescentes (desde 16 años). Población clínica ambulatoria y comunitaria general.
Tiempo de Administración	8 a 12 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico asistencial, docencia e investigación científica.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TRANSACCIONAL DE SANDÍN & CHOROT

El CAE se fundamenta en la teoría transaccional del estrés de Lazarus y Folkman (1984), perfeccionada conceptual y métricamente por Sandín y Chorot (2003) para subsanar los solapamientos empíricos de las escalas tradicionales anglosajonas. El afrontamiento (**coping**) se conceptualiza como el conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que desarrolla el individuo para manejar las demandas específicas externas o internas evaluadas como excedentes o desbordantes de sus propios recursos.

El instrumento evalúa 7 estilos operativamente independientes que se integran en dos dimensiones de orden superior:

- Afrontamiento Racional / Activo:** Enfocado en modificar el estresor o su significado mediante la resolución de problemas (FSP), la reevaluación positiva (REP) y la autorregulación fisiológica (AC).
- Afrontamiento Emocional / Pasivo:** Centrado en la gestión del malestar reactivo mediante la búsqueda de apoyo (BAS), la religión (RL), la evitación o escape cognitivo (EV) y el desahogo emocional (EEA).

Desde la neurociencia afectiva, las estrategias activas activan la corteza prefrontal dorsolateral (DLPFC) y el cíngulo anterior, facilitando la modulación inhibitoria parasimpática; las formas evitativas y de desahogo explosivo se asocian a hiperexcitabilidad amigdalina y elevación crónica del cortisol.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN FACTORIAL DE ÍTEMS

Estrategia de Afrontamiento	Ítems (42)	Sentido	Definición Operativa y Foco Clínico Evaluado
1. Focalización Solución (FSP)	1, 8, 15, 22, 29, 36	Directos (6)	Acciones sistemáticas para resolver directamente la situación estresante.
2. Autocalmado (AC)	2, 9, 16, 23, 30, 37	Directos (6)	Estrategias para conservar la serenidad y regular la reactividad autonómica.
3. Reevaluación Positiva (REP)	3, 10, 17, 24, 31, 38	Directos (6)	Reestructuración cognitiva para extraer aspectos formativos o constructivos.
4. Expresión Emocional (EEA)	4, 11, 18, 25, 32, 39	Directos (6)	Descarga conductual abierta del malestar, enfado, llanto o queja.
5. Evitación (EV)	5, 12, 19, 26, 33, 40	Directos (6)	Distracción pasiva, negación o intentos de olvidar el problema.
6. Apoyo Social (BAS)	6, 13, 20, 27, 34, 41	Directos (6)	Búsqueda activa de consejo, ayuda tangible o escucha empática en otros.
7. Religión (RL)	7, 14, 21, 28, 35, 42	Directos (6)	Rezo, asistencia a cultos o fe espiritual como amparo frente a la adversidad.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Solidez psicométrica en población española (Sandín & Chorot, 2003; N = 561): alfa de Cronbach de 0.85 (FSP), 0.85 (BAS), 0.84 (RL), 0.76 (EEA), 0.71 (REP), 0.64 (AC) y 0.64 (EV). Fiabilidad test-retest $r = 0.68$ a 0.82 a las 6 semanas.
Estructura Factorial	Los análisis factoriales exploratorios y confirmatorios corroboran de forma concluyente una estructura de 7 factores primarios oblicuos que dan cuenta del 56.4% de la varianza total de los datos.
Validez Concurrente / Divergente	FSP y REP presentan correlaciones directas robustas con afecto positivo (PANAS-P, $r = 0.42$ a 0.48) y optimismo (LOT-R, $r = 0.38$). Por el contrario, Evitación (EV) y Expresión Emocional Abierta (EEA) correlacionan directamente con afecto negativo (PANAS-N, $r = 0.44$ a 0.52), ansiedad rasgo (STAI, $r = 0.46$) y sintomatología somática general.
Sensibilidad al Cambio Clínico	El CAE es altamente sensible a programas de TCC, observándose incrementos en FSP y REP acompañados de reducciones significativas en EV y EEA tras módulos de resolución de problemas.
Diferencias Sociodemográficas	Las mujeres puntúan significativamente más alto en Búsqueda de Apoyo Social (BAS) y Expresión Emocional Abierta (EEA), mientras que los varones muestran tendencias superiores en Autocalmado (AC).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 42 ítems se responde en escala Likert de 5 puntos (**0** = «Nunca», **1** = «Pocas veces», **2** = «A veces», **3** = «A menudo», **4** = «Casi siempre»):

- **Paso 1 (Cálculo Directo sin Ítems Invertidos):** Todos los ítems son directos dentro de su escala (puntuación de 0 a 4).
- **Paso 2 (Puntuaciones por Subescala):** Se suman los 6 reactivos correspondientes a cada una de las 7 dimensiones.
- **Rango Teórico por Subescala: 0 a 24 puntos.** No se recomienda computar una puntuación total agregada, ya que las subescalas representan mecanismos funcionalmente independientes y cualitativamente diversos.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y BAREMOS NORMATIVOS (SANDÍN & CHOROT, 2003)

Estratificación	Puntuación Subescala	Nivel de Implementación	Interpretación Clínica Funcional
Bajo	0 a 7 puntos	Uso raro o infrecuente	Estrategia escasamente empleada por el individuo ante situaciones conflictivas.
Medio / Típico	8 a 15 puntos	Uso moderado / situacional	Empleo flexible ante sobrecargas habituales; repertorio dentro de la media normativa comunitaria.
Alto / Pre-dominante	16 a 24 puntos	Estrategia nuclear preferente	Mecanismo predominante de gestión del estrés; define el estilo de afrontamiento habitual del sujeto.

PERFIL CLÍNICO DE ALTO RIESGO PSICOPATOLÓGICO:

El patrón de vulnerabilidad clínica por excelencia se caracteriza por: **Evitación elevada (EV ≥ 16)** combinada con **Expresión Emocional Abierta alta (EEA ≥ 16)** y **Focalización en el Problema baja (FSP ≤ 8)**. Este perfil refleja un sujeto que se desborda afectivamente sin canalizar la emoción y que rehúye resolver las causas objetivas del conflicto, asociándose fuertemente a distimia, dolor crónico y trastornos de ansiedad.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN PERFILES DESADAPTATIVOS DE COPING

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN BASADO EN EL PERFIL DEL CAE:

- **Paso 1 (Detección del Estilo Dominante):** Representar el perfil gráfico de las 7 subescalas. Identificar si predomina el afrontamiento racional (FSP, REP, AC) o el pasivo-emocional desregulado (EV, EEA).
- **Paso 2 (Módulo de Entrenamiento en Solución de Problemas):** Si FSP < 10, instaurar el protocolo estructurado de D'Zurilla y Nezu (definición operativa, tormenta de ideas, toma de decisiones, puesta en práctica y verificación).
- **Paso 3 (Reestructuración Cognitiva y Regulación Afectiva):** Si REP < 10 y EEA > 16, trabajar la búsqueda de significados alternativos y técnicas de desactivación fisiológica (respiración diafragmática, autocalmado guiado).
- **Paso 4 (Evaluación Post-Tratamiento):** El éxito terapéutico se evidencia cuando FSP y REP aumentan ≥ 6 puntos y EV desciende ≥ 6 puntos.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN SÍNDROME DE BURNOUT Y ANSIEDAD LABORAL

Identificación: Mujer de 37 años, jefa de enfermería en unidad hospitalaria de cuidados críticos, que consulta por cefaleas tensionales crónicas, irritabilidad extrema, labilidad emocional e insomnio. Cumple criterios de Síndrome de Burnout severo.

Evaluación Inicial CAE (Línea Base): FSP = 5/24 (Bajo); AC = 6/24 (Bajo); REP = 4/24 (Bajo); EEA = 22/24 (Extremo); EV = 20/24 (Alto); BAS = 8/24 (Medio); RL = 2/24 (Bajo). Perfil clásico de desborde reactivo y parálisis resolutoria ante el conflicto jerárquico.

Intervención Implementada: Programa TCC de 12 sesiones: (a) dismantelamiento de conductas de evitación y postergación de quejas; (b) entrenamiento asertivo y solución de problemas con la dirección médica; (c) biofeedback y técnicas de autocalmado en turnos de guardia.

Reevaluación a las 12 Semanas: FSP ascendió a 19/24 (+14 pts); REP aumentó a 16/24 (+12 pts); AC alcanzó 17/24 (+11 pts); mientras que EEA descendió drásticamente a 8/24 (-14 pts) y EV bajó a 7/24 (-13 pts). La sintomatología psicósomática remitió casi en su totalidad.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

DESAHOGO EMOCIONAL VS. CATARSIS DAÑINA:

Puntuaciones máximas en Expresión Emocional Abierta (EEA) no indican necesariamente un afrontamiento adaptativo. En pacientes limítrofes o depresivos, el desahogo verbal reiterado sin reestructuración consolida la rumiación interpersonal y la cronificación afectiva.

VALOR CONTEXTUAL DE LA RELIGIÓN / APOYO:

El empleo de la Religión (RL) o el Apoyo Social (BAS) no debe interpretarse como debilidad resolutoria. En situaciones objetivamente inmodificables (duelo, enfermedad médica terminal), ambas estrategias constituyen pilares de resiliencia existencial de primer orden.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Sandín, B., & Chorot, P. (2003). Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE): Desarrollo y validación preliminar. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 8(1), 39-54.
2. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer Publishing Company.
3. D'Zurilla, T. J., & Nezu, A. M. (2007). *Problem-solving therapy: A positive approach to clinical intervention*. Springer Publishing Company.
4. González-Cabrera, J., et al. (2014). Propiedades psicométricas del Cuestionario de Afrontamiento del Estrés en población universitaria. *Anales de Psicología*, 30(2), 522-530.